

Convulsiones febriles

1. Introducción y relevancia clínica

Las **convulsiones febriles (CF)** son el **trastorno convulsivo más común en pediatría**, afectando a cerca del **2–5 % de los niños** entre los **6 meses y 5 años**.

Se definen como **episodios convulsivos asociados a fiebre $\geq 38^{\circ}\text{C}$ sin evidencia de infección intracraneal ni otra causa neurológica**.

La gran mayoría son **benignas y autolimitadas**, pero generan gran alarma en los padres y en los profesionales menos experimentados.

Su **relevancia clínica y en EUNACOM** radica en:

- Reconocer **qué es una convulsión febril simple vs compleja**.
- Saber **qué exámenes son necesarios (y cuáles no)**.
- Manejar adecuadamente la **fase aguda y la prevención de recurrencias**.

En Chile, el manejo está regido por la **Guía Clínica MINSAL “Convulsiones Febriles en Pediatría” (2021)** y las **recomendaciones de la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIFE)**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El cerebro infantil es más **excitable y susceptible a la fiebre** debido a:

- Menor umbral convulsivo (inmadurez neuronal y de neurotransmisores inhibitorios).
- Mayor respuesta metabólica a la hipertermia.
- Factores genéticos: antecedentes familiares aumentan el riesgo 2–3 veces.

El mecanismo exacto no es estructural ni infeccioso, sino **funcional y transitorio**, provocado por la fiebre como desencadenante.

- ☐ No existe daño cerebral directo en la mayoría de las convulsiones febriles simples.
-

3. Clasificación

Tipo	Criterios	Características clínicas	Riesgo de recurrencia / epilepsia
Simple	- Generalizada (tónico-clónica) - Duración <15 min - No se repite en 24 h - Sin déficit neurológico previo	80–85 % de los casos	Bajo (<2–3 %)
Compleja (atípica)	- Focal - Duración >15 min - Se repite en 24 h - Alteraciones neurológicas previas	15–20 % de los casos	Moderado (hasta 10 %)

□ “Compleja” no implica epilepsia, pero requiere estudio más dirigido.

4. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a.

Presentación típica (convulsión febril simple)

- Edad: 6 meses – 5 años.
- Fiebre $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (sin foco intracraneal).
- Crisis **tónico-clónica generalizada**, breve (<5–10 min).
- Recuperación rápida, sin déficit focal ni estado posictal prolongado.
- No hay signos meníngeos ni alteración de conciencia persistente.

b.

Diagnóstico diferencial

Causa

Características diferenciales

Epilepsia	Crisis afebril o repetida sin fiebre.
Meningitis / encefalitis	Fiebre + alteración de conciencia prolongada o signos meníngeos.
Convulsión hipocalcémica o hipoglucémica	No asociada a fiebre, alteraciones metabólicas.
Síndrome febril sin foco	Fiebre sin crisis.

En lactantes <12 meses, la meningitis debe **siempre descartarse clínicamente**.

5. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a.

Diagnóstico clínico

Se basa en:

1. Edad 6 meses–5 años.
2. Fiebre $\geq 38^{\circ}\text{C}$.
3. Crisis convulsiva autolimitada.
4. Ausencia de signos de infección del SNC o causa metabólica.

b.

Exámenes según tipo de convulsión

Situación clínica

Exámenes sugeridos

Convulsión febril simple, niño sano	No requiere exámenes complementarios.
--	--

<12 meses o con signos meníngeos	Punción lumbar (descartar meningitis).
--	--

Compleja o focal	EEG o neuroimagen diferida (RM) según evolución.
-------------------------	--

Convulsión prolongada (>15 min)	Glicemia, electrolitos, calcemia.
---	-----------------------------------

Primera CF en <6 meses o >5 años	Evaluar causas estructurales o metabólicas.
---	---

☐ En EUNACOM: "Convulsión tónico-clónica generalizada <5 min, 1er episodio, niño 2 años, fiebre 39°C → **no requiere TAC ni EEG.**"

6. Manejo

a.

Durante la crisis (fase aguda)

1. **Mantener vía aérea permeable.**
2. **Decúbito lateral de seguridad.**
3. **No introducir objetos en boca.**
4. **Si >5 minutos o crisis recurrente:**
 - **Diazepam 0,3 mg/kg EV o 0,5 mg/kg rectal.**
 - **Alternativa: Midazolam 0,2 mg/kg intranasal o bucal.**

Si persiste >10–15 min → manejo como **estatus epiléptico febril.**

b.

Postcrisis

- Evaluar causa de la fiebre (habitualmente viral).
 - Antipiréticos: **paracetamol o ibuprofeno** (para confort, no previene recurrencias).
 - Observar 2–4 h en urgencia.
 - Si recuperación completa → alta con educación parental.
-

c.

Profilaxis anticonvulsivante

No se recomienda profilaxis continua ni intermitente.

Estudios muestran que **no previene epilepsia ni mejora pronóstico.**

Excepcionalmente, puede considerarse **diazepam oral intermitente (0,3 mg/kg cada 8 h durante la fiebre)** en:

- Niños con crisis prolongadas o repetidas.
 - Alta ansiedad parental con seguimiento médico cercano.
-

7. Pronóstico y riesgo de recurrencia

Factor	Riesgo aumentado de recurrencia
Edad <18 meses al primer episodio	↑ Riesgo
Antecedentes familiares de CF	↑ Riesgo

Fiebre moderada (38–39 °C) al momento de crisis ↑ Riesgo

Intervalo corto entre inicio de fiebre y crisis ↑ Riesgo

Recurre en ~30–40 % de los niños, pero **la mayoría antes de los 3 años**.
El riesgo de **epilepsia posterior** es **≈1–2 % (similar a población general)** en CF simples.

8. Complicaciones

- **Estatus epiléptico febril:** crisis prolongada >30 min (raro).
- **Trauma accidental durante la convulsión.**
- **Convulsión febril compleja:** puede requerir estudio más profundo.

No hay evidencia de daño neurológico ni cognitivo en CF simples.

9. Educación y orientación a padres

Puntos clave:

1. Las CF son **benignas y transitorias**.
2. No se asocian con epilepsia ni déficit intelectual.
3. Enseñar manejo domiciliario:
 - Acostar al niño de lado.
 - No meter objetos en la boca.
 - Controlar tiempo de crisis.
 - Acudir a urgencia si >5 minutos o no recupera conciencia.
4. Uso correcto de antipiréticos solo para confort.
5. No administrar fármacos anticonvulsivantes sin indicación médica.

10. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. **Edad típica:** 6 meses a 5 años.
2. **Crisis generalizada, breve, única:** convulsión febril simple.
3. **No requiere TAC ni EEG.**
4. **Manejo agudo:** diazepam si crisis >5 min.
5. **Antipiréticos no previenen recurrencia.**
6. **Profilaxis anticonvulsivante no indicada.**
7. **Buen pronóstico neurológico.**

☐ Errores frecuentes:

- Realizar neuroimagen o EEG innecesarios.
- Iniciar fenobarbital profiláctico (ya obsoleto).
- No descartar meningitis en menores de 12 meses.
- Asumir epilepsia tras una CF simple.
- No educar adecuadamente a los padres.

11. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Convulsión febril:** crisis asociada a fiebre $\geq 38^{\circ}\text{C}$ sin infección del SNC.
2. **Edad típica:** 6 meses a 5 años.
3. **Simple:** generalizada, <15 min, única en 24 h, sin déficit.
4. **Diagnóstico clínico:** no requiere EEG ni neuroimagen.

5. **Tratamiento:** diazepam si >5 min; luego observación.
6. **Pronóstico excelente:** sin daño cerebral ni secuelas.
7. **Educación a padres** es esencial en el manejo.